carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la Disfunción Física

Semana 11

Enfermedades neurodegenerativas II

Presente.

CASO CLÍNICO:

Paciente mujer de 33 años que acude a su médico de cabecera por presentar cuadro de 2 meses de evolución de parestesias y pérdida de fuerza en la pierna derecha que le ocasiona problemas en la marcha. Describe sensación de que cuando camina y desciende escaleras no nota el suelo.

Además, refiere visión borrosa desde hace una semana, junto con fatiga intensa que se hace más pronunciada al caer la tarde. No presenta otros síntomas y niega tener alguna enfermedad o antecedentes de interés.

Después de analizar el caso, respondan:

- ¿CUALES SERIAN LOS POSIBLES DIAGNÓSTICOS?
- ¿TENDRA CURA?

https://www.youtube.com/watch?v=rp-v5au9Cxw

Después de ver el video…

1. Cómo llegaron al diagnóstico?
2. Menciona 5 síntomas del paciente
3. ¿Que pensaba el paciente de sus síntomas?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las causas, los signos, síntomas y el diagnóstico que se debe aplicar en enfermedades neurodegenerativas en un análisis de casos.

Temario:

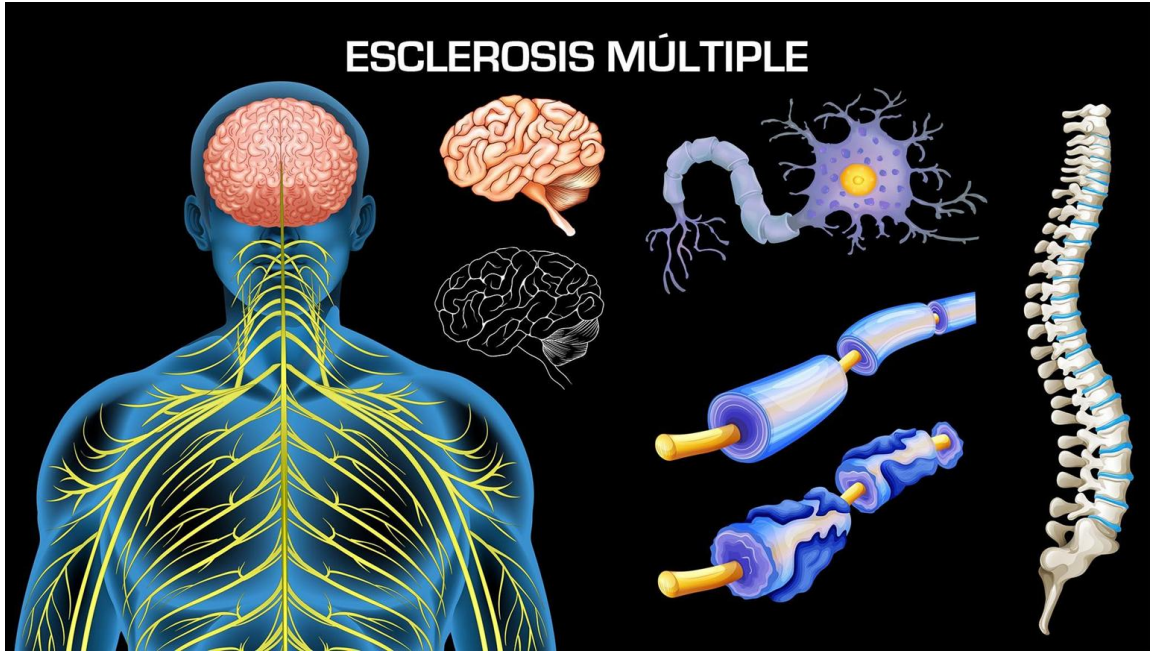
Enfermedades neurodegenerativas II

1 Esclerosis múltiple

- Concepto
- signos y síntomas
- causas
- diagnóstico

2 Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

- concepto
- signos y síntomas
- causas
- diagnóstico



Extraído de: https://www.andaluciamedica.es/2018/05/30/30-de-mayo-dia-mundial-de-la-esclerosis-multiple/

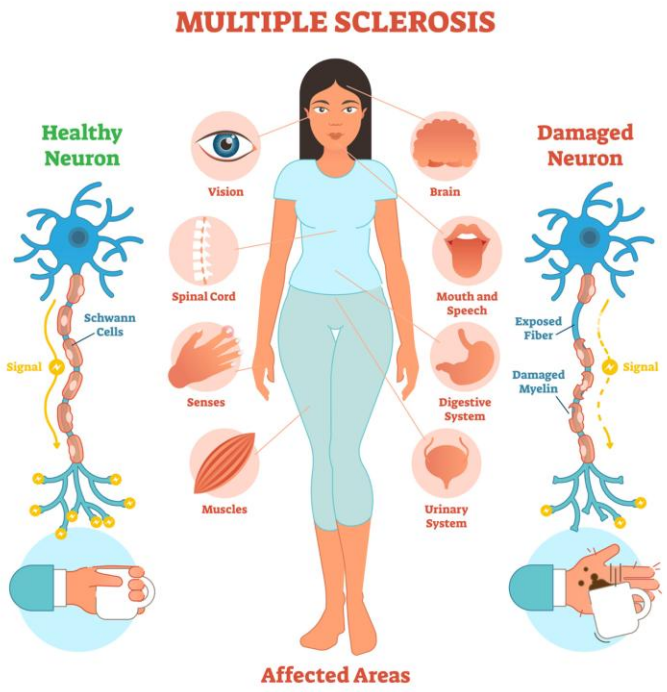
CONCEPTUALIZACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

- La esclerosis múltiple (EM) es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas (mielina) del Sistema Nervioso Central (SNC). En los adultos jóvenes ocupa el primer puesto entre los trastornos neurológicos que causan incapacidad.
- La esclerosis múltiple conlleva la destrucción preferentemente de la vaina mielínica de las fibras nerviosas, aunque también se dañan las propias fibras nerviosas (axones), en el sistema nervioso central.
- Afecta a encéfalo y médula espinal de modo diseminado, con cierta predilección por nervios ópticos, sustancia blanca del cerebro, tronco cerebral y médula espinal.

Extraído de: https://canalsalud.imq.es/blog/esclerosis-multiple-sintomas-y-tratamiento

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Entumecimiento o debilidad en una o más extremidades que se produce típicamente en un lado del cuerpo a la vez, o en las piernas y el tronco
- Sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, en especial, al inclinarlo hacia adelante (signo de Lhermitte)
- Temblores, falta de coordinación o marcha inestable
- Los problemas de visión también son frecuentes, incluidos:
- Pérdida de visión parcial o completa, por lo general en un ojo a la vez, a menudo con dolor al mover el ojo
- Visión doble prolongada
- Visión borrosa
- Los síntomas de la esclerosis múltiple también pueden incluir:
- Hablar arrastrando las palabras
- Fatiga
- Mareos
- Hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo
- Problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga



https://www.misistemainmune.es/enfermedades-sistema-inmunitario/sistema-nervioso/esclerosis-multiple-una-enfermedad-del-sistema-nervioso

CAUSAS

- Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple. Se considera una enfermedad autoinmunitaria en la cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propios tejidos. En el caso de la esclerosis múltiple, este mal funcionamiento del sistema inmunitario destruye la sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal (mielina).
- La mielina se puede comparar con la capa aislante que recubre los cables eléctricos. Cuando la mielina protectora se daña y la fibra nerviosa queda expuesta, los mensajes enviados a través de esa fibra nerviosa son más lentos o se interrumpen.
- No está claro por qué la esclerosis múltiple se manifiesta en algunas personas y en otras no. Parece deberse a una combinación de factores genéticos y ambientales.

DIAGNÓSTICO

- El diagnóstico de la Esclerosis Múltiple, conocida como la enfermedad de las mil caras por la diversidad de sus síntomas, es muy complejo y suele requerir un cierto tiempo.
- Actualmente la “regla” básica para efectuar un diagnóstico de la Esclerosis Múltiple requiere que se reúnan las dos condiciones siguientes:
- Que existan pruebas objetivas de al menos dos áreas de pérdida de mielina, o lesiones de desmielinización, que aparezcan en dos zonas neurológicas distintas y separadas en el tiempo. Esto significa que las lesiones se han presentado en diferentes lugares y diferentes ocasiones dentro del cerebro, la médula espinal, o el nervio óptico.
- Que se hayan descartado objetivamente el resto de enfermedades que pueden causar síntomas neurológicos similares.
- Para confirmar el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple se necesitan dos tipologías de pruebas:
- El examen físico
- Pruebas diagnósticas

https://www.pinterest.com/pin/327918416615929790/

https://www.youtube.com/watch?v=e2jrxLsMlDc

Después de ver el video…

1. ¿Qué es ELA?
2. ¿Cómo se caracteriza la enfermedad?
3. ¿Cual es el pronóstico del paciente con ELA?

CONCEPTUALIZACIÓN ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

- La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular.
- La ELA a menudo se llama enfermedad de Lou Gehrig, en honor al jugador de béisbol al que se le diagnosticó la enfermedad.
- La ELA a menudo comienza con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar.
- Eventualmente, la ELA afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar. No hay cura para esta enfermedad mortal.

https://www.urbanfisio.com/la-esclerosis-lateral-amiotrofica-ela/

SÍNTOMAS

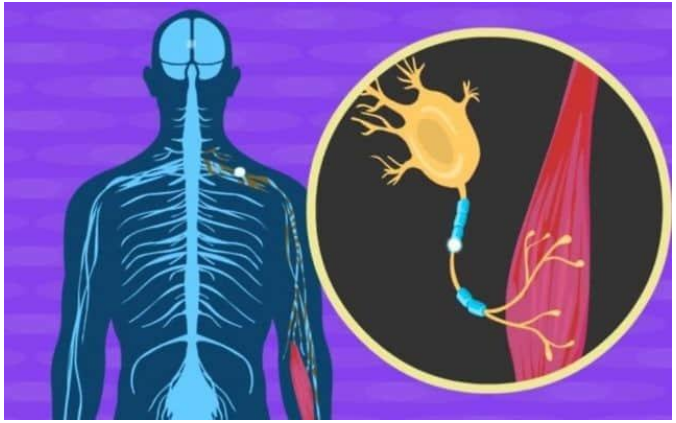
Los signos y síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica varían mucho de una persona a otra, según qué neuronas están afectadas. Suele comenzar con debilidad muscular que se propaga y empeora con el tiempo. Estos son algunos de los signos y síntomas posibles:

- Dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales
- Tropezones y caídas
- Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos
- Debilidad o torpeza en las manos
- Dificultad para hablar o problemas para tragar
- Calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua
- Llanto, risa o bostezos inapropiados
- Cambios cognitivos y de comportamiento

https://www.pinterest.es/pin/801218589951604771/

CAUSAS

- La ELA afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como caminar y hablar (neuronas motoras). La ELA hace que las neuronas motoras se deterioran gradualmente y luego mueran. Las neuronas motoras se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo. Cuando las neuronas motoras están dañadas, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que los músculos no pueden funcionar.
- La ELA se hereda en el 5 % al 10 % de las personas. Se desconoce la causa en el resto de las personas.
- Los investigadores continúan estudiando las posibles causas de la ELA. La mayoría de las teorías se centran en una interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales.



https://drdiegodecastro.com/esclerose-lateral-amiotrofica/

DIAGNÓSTICO

- **Electromiografía.** El médico inserta un electrodo de aguja a través de la piel en varios músculos. El análisis evalúa la actividad eléctrica de los músculos cuando se contraen y cuando están en reposo.
- Las anomalías en los músculos que se observan en una electromiografía pueden ayudar a los médicos a diagnosticar o descartar la esclerosis lateral amiotrófica. Una electromiografía también puede ayudar a guiar tu terapia de ejercicio.
- **Estudio de conducción nerviosa.** Este estudio mide la capacidad de los nervios para enviar impulsos a los músculos en distintas áreas del cuerpo. Esta prueba puede determinar si tienes daño en los nervios o ciertas enfermedades musculares o nerviosas.
- **Resonancia magnética.** Mediante el uso de ondas de radio y un potente campo magnético, una resonancia magnética produce imágenes detalladas del cerebro y de la médula espinal.
- **Análisis de sangre y de orina.** El análisis de muestras de sangre y orina en el laboratorio podría ayudar al médico a eliminar otras causas posibles de los signos y síntomas.
- **Punción lumbar (punción medular).** Esto implica extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo para realizar pruebas de laboratorio mediante el uso de una pequeña aguja que se inserta entre dos vértebras en la región lumbar.
- **Biopsia muscular.** Si el médico cree que podrías tener una enfermedad muscular en lugar de esclerosis lateral amiotrófica, podrías someterte a una biopsia muscular.

ACTIVIDAD ASINCRÓNICA

Elabora un resumen de la importancia de las enfermedades luego de realizar un análisis de casos.

CONCLUSIONES

1. En los últimos años las enfermedades neurodegenerativas (esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica) ha habido un cambio en la esperanza de vida y la supervivencia en los pacientes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

REFERENCIAS

- Zapata-Zapata CH, Universidad de Antioquia, Franco-Dáger E, Solano-Atehortúa JM, Ahunca-Velásquez LF, Universidad de Antioquia, et al. Esclerosis lateral amiotrófica: actualización. IATREIA [Internet]. 2016;29(2). Disponible en: http://dx.doi.org/10.17533/udea.iatreia.v29n2a08
- Carretero Ares JL, Bowakim Dib W, Acebes Rey JM. Actualización: esclerosis múltiple. Medifam [Internet]. 2001;11(9). Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/s1131-57682001000900002

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.